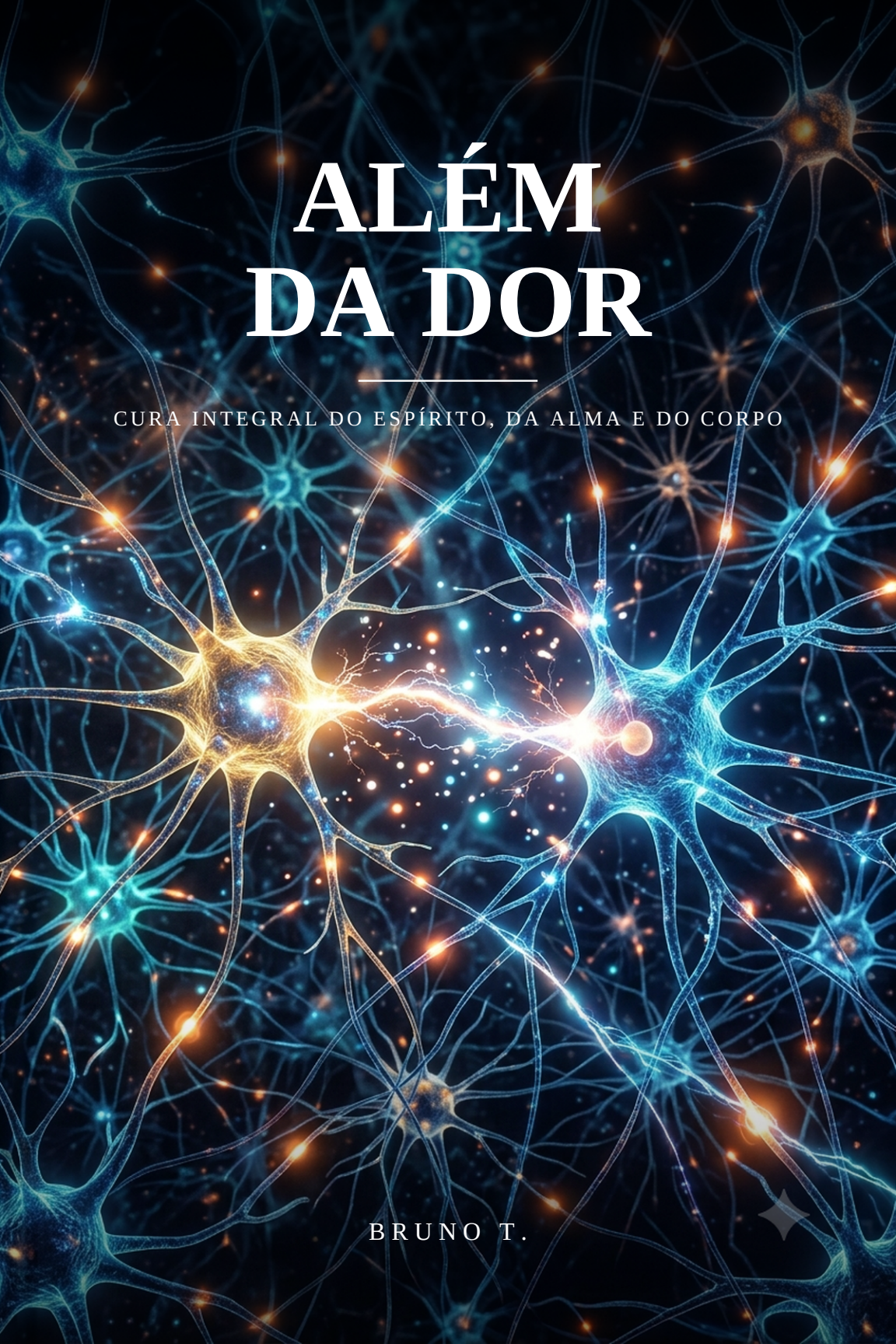




ALÉM DA DOR

CURA INTEGRAL DO ESPÍRITO, DA ALMA E DO CORPO

BRUNO T.





ALÉM DA DOR

*Cura integral do espírito,
da alma e do corpo*

Bruno T.

BPR Physical Rehabilitation

*À minha esposa e meu descanso;
aos meus filhos, razão diária do meu propósito;
aos meus pais e à minha família, que me deram raízes e me
sustentam.*

*E a cada pessoa que carrega uma dor e, ainda assim, ousa
esperar:
este livro é para você.*

A dor que fala

Deixa eu começar com uma confissão que talvez você não espere de um livro sobre a dor: eu não escrevo isto de longe.

Boa parte do que você vai ler aqui eu aprendi primeiro no meu próprio corpo, e só depois nos livros. Conheço a dor que acorda a pessoa de madrugada, a que rouba planos inteiros, a que faz o futuro parecer menor do que era ontem. E conheço também o outro lado — o dia em que a dor, que parecia só destruir, começou a dizer alguma coisa. Foi quando aprendi a escutá-la que tudo mudou. É essa escuta que eu quero te ensinar.

Porque a dor fala. Nós é que, quase sempre, não sabemos a língua dela.

Aprendemos a tratar a dor como uma inimiga: algo a ser calado o mais rápido possível, com um comprimido, um procedimento, uma distração. E, às vezes, calá-la é mesmo o certo. Mas, quando a dor insiste — quando ela volta, ou não vai embora, ou aparece sem que nenhum exame explique o porquê —, tratá-la só como inimiga é perder a mensagem que ela veio trazer. Porque a dor, no fundo, é uma **mensageira**. Ela não é o problema em si; é o alarme que aponta para o problema. E há uma diferença enorme entre desligar um alarme e resolver o que ele está tentando dizer.

Este livro nasceu de uma convicção simples, que a minha história e o meu trabalho só fizeram confirmar: **o ser humano não é feito de pedaços**. A medicina moderna, brilhante em tantas coisas, aprendeu a nos dividir — um médico para o osso, outro para a mente, e, se sobrar, alguém para o espírito, num horário separado. Mas você não vive em pedaços. Você é um só. E a sua dor, quase sempre, também é: ela circula entre o corpo, a alma e o espírito com uma liberdade que os nossos consultórios teimam em ignorar. Um estresse não resolvido vira dor nas costas. Um vazio de sentido vira um cansaço que o sono não

cura. Um corpo mal cuidado abate a alma. Tratar um sem olhar para os outros é, no fim, tratar metade da pessoa.

Foi por isso que organizei este livro em torno de uma frase muito antiga, escrita há quase dois mil anos: *"o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros"* (1 Tessalonicenses 5:23). Três dimensões, um só ser. É esse o mapa que vamos percorrer, e ele dá o desenho das quatro partes que você tem pela frente. Começaremos pelo **corpo** — porque é onde a dor grita primeiro, e porque há ali maravilhas que vão mudar a forma como você entende cada dor que já sentiu. Subiremos para a **alma** — a mente, as emoções, a pressa do mundo — e veremos como o que carregamos por dentro se instala na carne. Desceremos ao lugar mais profundo, o **espírito** — a dimensão que a nossa época quase esqueceu, e onde mora um vazio que nenhuma outra coisa preenche. E terminaremos na **integração**: como cuidar dos três juntos, na rotina de uma vida real, rumo a um propósito.

Preciso, logo aqui na porta de entrada, fazer duas promessas a você — e uma advertência.

A primeira promessa é de **honestidade científica**. Cada mecanismo, cada estudo, cada número que eu citar é real e está referenciado no fim de cada capítulo. Eu não vou te vender milagres, frequências mágicas nem curas garantidas. A ciência da dor, de verdade, já é espantosa o bastante; não precisa de enfeite.

A segunda promessa é de **honestidade espiritual**. Eu sou uma pessoa de fé, e não vou fingir que não sou — a dimensão do espírito tem, para mim, um peso que este livro não esconderia sem se trair. Mas fé, aqui, nunca será usada para culpar quem sofre, nem para prometer o que não se pode cumprir. Vou tratá-la com o mesmo cuidado e a mesma verdade com que trato a ciência. E vou te mostrar algo que me encanta: quantas vezes a sabedoria antiga e a descoberta moderna, quando honestas, dizem a mesma coisa em línguas diferentes. É essa combinação — fé e ciência lado a lado, sem que uma diminua a outra — o coração deste livro.

A advertência é curta: **este livro não substitui o seu médico nem o seu terapeuta**. Ele é um mapa, não um diagnóstico. Uma dor nova, que muda de padrão ou que vem acompanhada de sinais de alerta, precisa de avaliação profissional — e parte da sabedoria é saber a hora de procurar ajuda. O que ofereço aqui trabalha *junto* com o bom cuidado de saúde, nunca no lugar dele.

Uma última palavra, antes de virarmos a página. Se você chegou a este livro carregando uma dor — no corpo, na alma ou nessa parte funda que a gente nem sempre sabe nomear —, quero que saiba, desde já, que a sua dor é real, que ela é conhecida, e que a sua história não terminou. Não prometo que ela vá embora ao fim da última página. Prometo algo melhor: que você vai aprender a escutá-la, a cuidar de si por inteiro, e a descobrir que existe vida — muita vida — para além dela.

A dor está falando. Vamos, juntos, aprender a ouvir.

A dor por dentro

Dois operários. Dois pregos. Dois destinos opostos — e, no meio deles, uma lição que vira do avesso quase tudo o que a gente acha que sabe sobre a dor.

O primeiro caso foi publicado numa das revistas de medicina mais respeitadas do mundo, o *British Medical Journal*, em 1995. Um pedreiro de 29 anos chegou ao pronto-socorro depois de saltar sobre um prego de quinze centímetros, que atravessou a sola da bota de lado a lado. Cada mínimo movimento do prego era insuportável. A dor era tão intensa que os médicos precisaram sedá-lo com fentanil e midazolam — remédios pesados — antes mesmo de tocar no ferimento. Só então retiraram o prego, puxando-o por baixo. E aí, quando removeram a bota, aconteceu algo que parecia um milagre: o prego havia passado **entre os dedos**. O pé estava intacto. Nem um arranhão, nem uma gota de sangue (Fisher, Hassan e O'Connor, 1995).

Agora segure essa imagem e coloque ao lado dela a história oposta. Um homem trabalhava com uma pistola de pregos quando a ferramenta disparou sem querer perto do seu rosto. Ele sentiu um baque, uma dor de dente leve, um hematoma no maxilar — e seguiu a vida. Comeu, dormiu, trabalhou. Seis dias depois, foi ao dentista por causa da tal "dor de dente". A radiografia revelou um prego de dez centímetros **cravado dentro da cabeça dele**, atravessando o crânio.

Um homem em agonia por um prego que não o tocou. Outro quase sem dor com um prego alojado no cérebro. Como isso é possível?

A resposta é a chave deste livro inteiro, então vale a pena dizê-la devagar:

A dor não é o dano. A dor é a interpretação que o seu cérebro faz do dano.

Nós crescemos achando que a dor é um relatório fiel do corpo: quanto mais dói, mais grave a lesão. É intuitivo — e é errado. A dor não é medida no lugar machucado. Ela é **produzida pelo cérebro**, depois que ele pesa uma única pergunta essencial: "*o quanto eu estou em perigo?*" No primeiro operário, os olhos viram um prego atravessando a bota, os colegas gritaram, tudo dizia "catástrofe" — e o cérebro produziu uma dor real e devastadora, mesmo sem nenhuma lesão. No segundo, nada dizia "perigo" — e o cérebro ficou quieto, apesar do dano gravíssimo.

Repare bem: nos dois casos a dor (ou a ausência dela) foi **real**. Ninguém estava fingindo. O ponto não é que a dor seja "invenção". O ponto é que a dor é uma **decisão** do sistema nervoso sobre o quanto você precisa se proteger — e não uma leitura automática do estrago (Moseley e Butler, 2015).

Para entender como essa decisão é tomada, vamos fazer o que o título deste capítulo promete: entrar por dentro. E, lá dentro, a dor tem cheiro, tem eletricidade e tem química.

A sopa do perigo: a química de uma dor que começa

Espalhados pela sua pele, músculos, articulações e órgãos existem milhões de terminações nervosas chamadas **nociceptores**. O nome vem do latim *nocere*, "ferir". E aqui já mora a primeira surpresa: eles não são "receptores de dor". São **detectores de perigo**. Eles não sentem dor — eles avisam.

O que faz um nociceptor disparar? Muitas vezes, química pura. Quando um tecido é machucado — uma torção, uma queimadura, um corte —, as células rompidas e o sistema imune despejam ali um verdadeiro **coquetel químico**: prostaglandinas, bradicinina, substância P, histamina, íons de hidrogênio (acidez) e ATP. Os cientistas apelidaram esse caldo de "sopa inflamatória". Ela faz duas coisas. Primeiro, ativa os sentinelas. Segundo — e é isto que explica por que uma área machucada fica sensível ao menor toque — ela **abaixa o limiar** dos nociceptores: deixa-os com o gatilho leve, prontos para disparar com

quase nada. É por isso que a pele ao redor de uma queimadura arde a um sopro. Não é a sua imaginação; é a química local turbinando os sensores.

Guarde essa palavra: **sensibilização**. Ela vai voltar, em versões cada vez mais profundas, ao longo do livro.

O interruptor mestre da dor

Quando o sentinela decide disparar, ele precisa transformar a ameaça em eletricidade — um impulso nervoso. E como um nervo, que é feito de carne, "produz eletricidade"? Abrindo comportas minúsculas na sua membrana por onde entram partículas de sódio carregadas. Essa enxurrada de sódio é o próprio impulso elétrico.

Uma dessas comportas tem nome e sobrenome: **Nav1.7**, um canal de sódio que fica justamente nos neurônios do perigo. E ele é tão central que merece uma história.

No início dos anos 2000, médicos no norte do Paquistão ficaram intrigados com um garoto que se apresentava nas ruas como uma espécie de artista da dor: ele atravessava os próprios braços com facas e caminhava sobre brasas — sem sentir absolutamente nada. Ele não era corajoso; ele era **incapaz de sentir dor**. Pesquisadores estudaram a família dele e de outras duas e descobriram a causa: uma mutação que **desliga o canal Nav1.7**. Sem esse canal, o sentinela não consegue disparar, o aviso nunca sai, e a pessoa vive num mundo sem dor (Cox et al., 2006). (A história tem um fim trágico e revelador: acredita-se que o garoto tenha morrido ao pular de um telhado, no dia do seu aniversário de catorze anos. Sem dor para adverti-lo, o perigo não tinha voz.)

Por que isso importa para você, que quer aliviar a sua dor? Porque, se existe um interruptor químico da dor, é possível **agir sobre ele**. Os anestésicos locais que o dentista injeta funcionam exatamente assim: bloqueiam os canais de sódio e o aviso não sobe. E os laboratórios do mundo inteiro correm atrás de um analgésico que mire o Nav1.7 — o sonho de um "desligador da dor" sem os efeitos dos opioides. A

química que causa a dor é também a porta para silenciá-la.

Por que a pimenta arde (e o que isso ensina sobre alívio)

Faça um teste mental: por que uma pimenta "queima" a boca, se ela não está quente? Porque os seus nociceptores têm um sensor de calor chamado **TRPV1** — e a capsaicina, a substância da pimenta, encaixa nesse sensor e o engana. O cérebro recebe o sinal "estou queimando" e produz ardência de verdade, sem nenhuma temperatura alta (Caterina et al., 1997). Foi uma descoberta tão fundamental que rendeu ao seu autor, David Julius, o Prêmio Nobel de Medicina de 2021.

E aqui vem a virada útil: esse mesmo sensor virou remédio. Cremes de **capsaicina** — sim, o princípio da pimenta — são usados para tratar certas dores. Ao estimular o TRPV1 de forma controlada e repetida, eles esgotam a substância P do nervo e, com o tempo, **dessensibilizam** aquela região. A química que arde, na dose e no jeito certos, também acalma.

A viagem do sinal e o portão que controla o volume

Uma vez disparado, o aviso de perigo corre por dentro dos nervos por duas "estradas". As fibras rápidas (A-delta) levam o alerta a toda velocidade — é aquela dor aguda e imediata que faz você tirar a mão do fogão antes mesmo de pensar. E as fibras lentas (fibras C) vêm logo atrás, mais devagar, carregando a dor surda, latejante, que insiste. Por isso a dor de uma batida costuma chegar em duas ondas.

O sinal sobe até a **medula espinhal** e chega a um primeiro posto de controle. Não é um cano de passagem: é um **portão**. Em 1965, dois cientistas, Ronald Melzack e Patrick Wall, publicaram na revista *Science* a **teoria da comporta** (Melzack e Wall, 1965). Eles explicaram algo que todo mundo faz sem pensar: quando você bate o cotovelo, esfrega o lugar — e alivia. Por quê? Porque, naquele portão, os sinais de dor disputam espaço com os sinais de tato. Ao esfregar, você inunda a comporta com tato e **abafa** parte do aviso de dor antes que ele suba.

E o mais impressionante: esse portão também recebe ordens **de cima para baixo**, do próprio cérebro, que pode mandar mensageiros descerem e **abrir ou fechar a comporta**. O seu cérebro tem, literalmente, um botão de volume da dor. É por isso que um soldado ferido em combate, ou um atleta no meio da partida, às vezes só percebe o machucado depois: o cérebro, ocupado com algo mais urgente, manteve a comporta fechada.

Só depois de passar por esse portão o sinal chega ao cérebro. E lá em cima não existe um único "centro da dor". Existe uma **rede** — várias regiões, incluindo as da emoção, da memória e do significado. Essa rede compara o aviso com tudo o que você é e só **então** decide produzir — ou não — a dor. Por isso vale repetir: **a dor não é algo que o corpo envia ao cérebro; é algo que o cérebro constrói**.

A farmácia dentro de você

Há ainda um detalhe que a maioria das pessoas nunca ouviu: o seu corpo fabrica os próprios analgésicos. Quando o cérebro decide baixar o volume da dor, ele libera substâncias chamadas **endorfinas** — parentes químicos da morfina, produzidos por você mesmo. É parte do que explica o "barato do corredor", o alívio estranho no meio de um susto, e até uma fatia do efeito placebo.

E o melhor: essa farmácia interna **pode ser aberta**. Movimento, risada, música, oração, o toque de quem se ama, um propósito que empurra você para a frente — tudo isso ajuda a liberar os próprios opioides do corpo. Você não é só uma vítima passiva da dor; você carrega, dentro de si, parte do remédio.

O presente que quase ninguém quer

Se a dor é tão trabalhosa — sopa química, canais de sódio, estradas, um portão, todo um tribunal no cérebro —, vale a pergunta: para que serve tudo isso? Não seria melhor uma vida sem dor?

Conheça Jo Cameron. Escocesa, hoje na casa dos setenta, ela viveu quase toda a vida sem saber que era diferente. Jo **praticamente não sente dor**. Também quase não sente medo nem ansiedade, e cicatriza depressa. Parece uma bênção — até você ouvir os detalhes. Jo já queimou a própria pele no fogão e só percebeu **pelo cheiro da carne queimando**, porque a dor nunca a avisou. Descobriu uma artrose grave no quadril só quando os médicos estranharam que uma articulação tão destruída não doía. Passou por cirurgias costumeiramente muito dolorosas usando pouco mais que um analgésico comum. A causa: mutações raras nos genes FAAH e FAAH-OUT, que deixam o volume da dor permanentemente baixo (Habib et al., 2019; Mikaeili et al., 2023).

A história de Jo, e a do garoto do Paquistão, ensina algo que a nossa cultura, obcecada em fugir do desconforto, esqueceu: **a dor é um presente**. É um sistema de alarme que nos mantém vivos. Quem nasce sem ele se fere sem perceber e costuma morrer jovem. A dor que você tanto quer calar é a mesma que já te fez tirar a mão do fogo e procurar ajuda a tempo. Ela não é a sua inimiga. É uma sentinela fiel.

E então, o que fazer com a dor? (as primeiras soluções)

Se você entendeu até aqui, já ganhou a primeira e mais poderosa ferramenta. Vamos organizar as soluções que nascem de tudo isso:

1. Entender a dor já a diminui. Parece bom demais, mas é ciência. Quando a pessoa compreende que dor não é sinônimo de dano — que o alarme às vezes exagera —, o cérebro passa a interpretar o sinal como menos ameaçador, e a dor de fato baixa. Programas de educação em dor reduzem dor e incapacidade de maneira medível (Louw et al., 2016; Moseley e Butler, 2015). Este capítulo, no fundo, já é tratamento.

2. Fechar a comporta. A teoria de Melzack e Wall virou ferramenta do dia a dia: esfregar o local, aplicar calor ou frio, ou usar um aparelho de **TENS** (que envia tato elétrico) ajudam a "fechar o portão" e abafar a dor. Alívio simples, e com base fisiológica real.

3. Mexer na química — com sabedoria. Anti-inflamatórios como a aspirina e o ibuprofeno funcionam bloqueando a produção das prostaglandinas daquela sopa inflamatória — uma descoberta que rendeu a John Vane o Nobel de 1982 (Vane, 1971). Eles têm lugar, especialmente na dor aguda. Mas têm limites: não resolvem a causa, e o uso prolongado cobra seu preço no estômago, nos rins e no coração. Cremes de capsaicina e adesivos anestésicos (que bloqueiam o sódio) são opções locais úteis para certas dores.

4. Abrir a farmácia interna. Movimento, sono, conexão e propósito liberam as suas próprias endorfinas. Não é "positividade" vazia; é bioquímica.

5. E a solução mais profunda de todas: dar **segurança** ao cérebro. Como o cérebro produz dor a partir da pergunta "o quanto estou em perigo?", tudo o que reduz a sensação de ameaça — entender, mover-se com confiança, dormir, acalmar a mente, ter esperança — baixa o volume na origem. É disto que o resto do livro vai tratar, camada por camada.

O corpo é uma maravilha — e isso não é só poesia

Pare um instante e olhe o que descrevemos. Sentinelas espalhados por todo o corpo. Uma sopa química que os desperta. Comportas de sódio que viram eletricidade. Duas estradas, uma rápida e uma lenta. Um portão que se abre e se fecha. Um cérebro que pesa perigo, memória, emoção e significado. E uma farmácia interna de analgésicos. Tudo isso em milésimos de segundo, sem você pedir, o tempo todo, para te proteger.

Faz três mil anos, um homem olhou para dentro de si sem microscópio nenhum e escreveu: *"Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui formado"* (Salmo 139:14). Ele não conhecia os nomes — nociceptor, Nav1.7, endorfina. Mas tinha a intuição certa. O corpo não é uma máquina burra que quebra e dói. É uma obra de engenharia de uma sabedoria que ainda nos deixa de queixo caído. E o sistema que

te faz sofrer é o mesmo que te guarda.

Isso muda a relação com a sua própria dor. Ela deixa de ser um castigo aleatório e volta a ser o que sempre foi: **uma mensageira**. A questão não é odiá-la nem apenas silenciá-la, mas aprender a escutar o que ela veio dizer — porque, como você vai ver, a mensagem raramente é só sobre o tecido.

Uma ressalva honesta

Preciso ser claro, para você não me entender errado. Dizer que o cérebro constrói a dor **não** significa que ela é "imaginação" ou "frescura". A dor é sempre real. E dizer que a dor nem sempre reflete o dano **não** significa que lesões não importem. Uma fratura, uma infecção, certos sinais de alerta continuam exigindo cuidado real e, às vezes, urgente. O que muda é isto: a dor não é uma régua confiável do estrago. Ela é uma protetora que, às vezes, exagera no alarme — e, às vezes, deixa de tocar quando deveria. Entender isso não diminui a sua dor. Liberta você para cuidar dela pelo caminho certo.

O que vem a seguir

Vimos como a dor nasce, viaja e é decidida — e por que, no fundo, ela existe para o seu bem. Mas isso levanta uma pergunta incômoda, que talvez seja a sua: *e quando o alarme simplesmente não desliga?* Quando a lesão já sarou faz tempo, mas a dor continua, mês após mês, ano após ano? Não é o corpo mentindo. É outra coisa — e é para dentro dela que vamos agora.

Referências

- Caterina, M.J., Schumacher, M.A., Tominaga, M. et al. (1997) 'The capsaicin receptor: a heat-activated ion channel in the pain pathway', *Nature*, 389(6653), pp. 816-824.
- Cox, J.J., Reimann, F., Nicholas, A.K. et al. (2006) 'An SCN9A channelopathy causes congenital inability to experience pain', *Nature*, 444(7121), pp. 894-898.
- Fisher, J.P., Hassan, D.T. e O'Connor, N. (1995) 'Minerva', *British Medical Journal*, 310, p. 70.

- Habib, A.M. et al. (2019) 'Microdeletion in a FAAH pseudogene identified in a patient with high anandamide concentrations and pain insensitivity', *British Journal of Anaesthesia*, 123(2), pp. e249-e253.
- Louw, A., Zimney, K., Puente-dura, E.J. e Diener, I. (2016) 'The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: a systematic review', *Physiotherapy Theory and Practice*, 32(5), pp. 332-355.
- Melzack, R. e Wall, P.D. (1965) 'Pain mechanisms: a new theory', *Science*, 150(3699), pp. 971-979.
- Mikaeili, H. et al. (2023) 'Molecular basis of the pain insensitivity phenotype', *Brain*, 146(9), awad098.
- Moseley, G.L. e Butler, D.S. (2015) 'Fifteen years of explaining pain', *The Journal of Pain*, 16(9), pp. 807-813.
- Vane, J.R. (1971) 'Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs', *Nature New Biology*, 231(25), pp. 232-235.
- Bíblia Sagrada*, Salmo 139:14.

O que vem pela frente

Neste livro

Você acabou de ler o Capítulo Um. Aqui está a jornada inteira que ele abre — doze capítulos, em quatro partes, do corpo até um propósito para além da dor.

PARTE UM — O CORPO

1 • A dor por dentro

Por que o mesmo prego pode deixar um homem em agonia e outro ileso — e o que isso revela sobre cada dor que você já sentiu.

2 • Quando o alarme não desliga

Como uma dor que sobreviveu à lesão ganha vida própria — e como um cérebro que aprendeu a doer pode reaprender a parar.

3 • O corpo como templo

Por que o repouso era a receita errada o tempo todo — e a descoberta de que você é muito mais do que um corpo.

PARTE DOIS — A ALMA

4 • O corpo guarda o que a alma carrega

Uma dor emocional capaz de mudar fisicamente o formato do seu coração — e as quatro vias ocultas por onde a alma se instala na carne.

5 • O mundo acelerado

Cadeiras gastas numa sala de espera, um truque de propaganda de 1929, e por que o celular no seu bolso mantém o sistema nervoso em alerta.

6 • Renovar a mente

Taxistas de Londres fizeram parte do cérebro crescer só de memorizar ruas — e o que isso significa para uma mente presa na dor.

7 • Perdão, gratidão e vínculo

Por que o rancor eleva a sua pressão, a gratidão alivia o corpo, e a solidão pode ser tão mortal quanto o cigarro.

PARTE TRÊS — O ESPÍRITO

8 • O espírito que estava morto

O vazio que nenhuma conquista preenche — e por que ele pode ser a coisa mais esperançosa deste livro.

9 · O novo nascimento

A virada de toda a história: como a parte mais profunda de uma pessoa pode voltar a viver — definitivamente.

10 · Fé, sentido e esperança

'A tua fé te curou' — dito com honestidade, sem os dois erros que ferem justamente quem mais sofre.

PARTE QUATRO — A INTEGRAÇÃO

11 · Rotinas de uma vida inteira

O único número onde corpo, alma e espírito se encontram — e ritmos diários simples que o movem na direção certa.

12 · Além da dor, o propósito

O que existe do outro lado da dor — e como aquilo que mais te feriu pode se tornar o seu presente para o mundo.



Aqui termina o Capítulo Um — o primeiro passo de *Além da Dor*.

O livro está sendo escrito agora, capítulo por capítulo, e você pode acompanhar toda a jornada. Cada novo capítulo chega primeiro a leitores como você.

bpr.rehab/alem-da-dor

Uma nota de honestidade: este livro não promete curas milagrosas nem soluções rápidas. Ele oferece algo mais confiável — um olhar honesto sobre como a dor realmente funciona, uma fé que nunca culpa quem sofre, e esperança real para a pessoa inteira. É um companheiro do seu cuidado, nunca um substituto do seu médico ou terapeuta.

© 2026 Bruno T. · BPR Physical Rehabilitation. Todos os direitos reservados.